小剂量地塞米松不能负反馈抑制下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴
（库欣综合征患者本就有大量GC↑,已经很大程度抑制）三、检查

M5(单):NaF抑制试验(+):NaF抑制率>50%

1.**确诊库欣综合征**：小剂量地塞米松抑制试验-（不能被小剂量地塞米松抑制）小征大病
定性　外源性GC-0.5mg → 内源性GC↓(抑制)　负反馈

以对照值50%为界
内源性GC被压到了50%以下
-能被抑制
反之-不被抑制

2.**定因定位**：~~下丘脑-腺垂体~~-肾上腺皮质轴　是否依赖ACTH

	大剂量地塞米松2mg抑制试验	CRH兴奋试验	ACTH兴奋试验	ACTH	影像学
依赖ACTH的库欣综合征：库欣病（只有库欣病在轴上）	+	+	+	略↑ 良性肿瘤	蝶鞍区异常 依赖ACTH的库欣综合征 双侧肾上腺皮质弥漫增生
依赖ACTH的库欣综合征：异位ACTH综合征	-	-	+	恶性肿瘤↑↑	双侧肾上腺皮质弥漫增生
不依赖ACTH的库欣综合征：肾上腺皮质瘤或癌	-	-	-	↓	多为单侧
不依赖ACTH的库欣综合征：双侧肾上腺小/大结节性增生	-	-	-	↓	双侧肾上腺皮质结节增生

表 7-7-1　不同病因库欣综合征的实验室及影像学检查鉴别诊断

检查项目	垂体性库欣病	肾上腺皮质腺瘤	肾上腺皮质癌	异位 ACTH 综合征
皮质醇多了：尿 17-羟皮质类固醇	一般中度增多，约 55～83μmol/24h	同库欣病	明显增高约 110～138μmol/24h	较肾上腺癌更高
皮质醇多了：尿 17-酮皮质类固醇	中度增多，69μmol/24h 左右	可为正常或增高	明显增高，可达 173μmol/24h 以上	明显增高，173μmol/24h 以上
皮质醇多了：血、尿皮质醇	轻中度升高	轻中度升高	重度升高	较肾上腺癌更高
大剂量地塞米松抑制试验①	多数能被抑制，少数不能被抑制	不能被抑制	不能被抑制	不能被抑制，少数可被抑制 类癌恶性程度低,ACTH略高,可被抑制
血浆 ACTH 测定	清晨略高于正常，晚上不像正常那样下降	降低	降低	明显增高，低度恶性者可轻度增高
低血钾性碱中毒	严重者可有	无	常有	常有
蝶鞍 X 线片	小部分患者蝶鞍扩大	不扩大	不扩大	不扩大
蝶鞍区 CT 扫描，MRI	大多示微腺瘤，少数示大腺瘤	无垂体瘤表现	无垂体瘤表现	无垂体瘤表现
肾上腺超声检查，CT 扫描，MRI	两侧肾上腺增大	显示肿瘤	显示肿瘤	两侧肾上腺增大

注：①每次 2mg，每 6 小时口服 1 次，连续 2 天，第 2 天尿 17-羟皮质类固醇或尿游离皮质醇降至对照值的 50% 以下者，表示被抑制。大剂量　大剂量地塞米松(+)

3.与肥胖症鉴别：腹型肥胖出现紫纹、妊娠出现妊娠纹:本质上都是弹力纤维断裂

	肥胖症	库欣综合征
不用皮质醇前体尿游离皮质醇不易受干扰	正常	↑
血皮质醇分泌昼夜节律	有	无（血皮质醇在晚上不下降）
小剂量地塞米松抑制试验	+	-

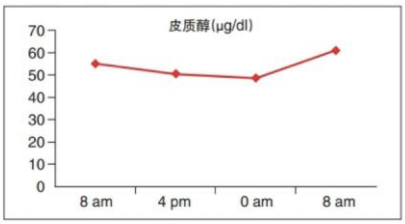


图1 血皮质醇昼夜曲线

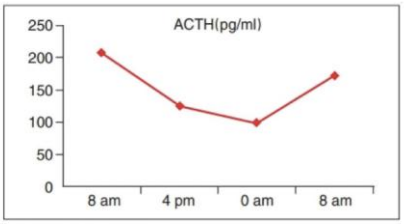


图2 血ACTH昼夜曲线